

Stabilizacja *przetwarzanie, integracja*

Faza 1 trwa miesiące do lat — i to nie opóźnienie, to fundament. Przejście do Fazy 2 bez stabilizacji prowadzi do retraumatyzacji.

CZAS: 10 min psychoedukacji **REALIZACJA:** cała terapia (2–5 lat lub dłużej)

ŹRÓDŁO: Herman (1992, *Trauma and Recovery*); Cloitre i in. (2011, 2012 RCT STAIR); ISTSS (2019, *Expert Consensus Guidelines*)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy fazy leczenia** C-PTSD: stabilizacja (Faza 1), przetwarzanie traumy (Faza 2), integracja i odbudowa relacji (Faza 3). W sekcji 02 — **kryteria gotowości** do Fazy 2 (kiedy stabilizacja wystarcza, by zacząć przetwarzanie). Sekcja 03 — **typowe ramy czasowe** i ostrzeżenie przed pośpiechem. Sekcja 04 — twoja samoocena, w której fazie jesteś.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Trójfazowy model leczenia traumy zaproponowała **Judith Herman** (1992, *Trauma and Recovery*) — jest fundamentem nowoczesnej traumatologii i pozostaje rekomendowany jako standard w wytycznych **ISTSS (2019, Expert Consensus Guidelines)** dla C-PTSD. W przeciwieństwie do klasycznego PTSD, gdzie można zacząć od ekspozycji (terapia *prolonged exposure* Foa lub *cognitive processing therapy* Resick), C-PTSD wymaga **najpierw stabilizacji** — bez niej przetwarzanie destabilizuje pacjenta. **Faza 1 — STABILIZACJA:** budowanie bezpieczeństwa (fizycznego, relacyjnego, emocjonalnego), nauka regulacji emocjonalnej (umiejętności DBT, podejście somatyczne, STAIR), *grounding* i praca z ciałem, psychoedukacja. Czas: tygodnie do **wielu lat** — nie ma presji czasowej. Kluczowy wskaźnik gotowości do Fazy 2: pacjent potrafi wejść w trudny materiał i wyjść z niego w ciągu sesji z *zachowaniem okna tolerancji*. **Faza 2 — PRZETWARZANIE TRAUMY:** EMDR z modyfikacjami (Twombly), STAIR + NST (Cloitre i in., 2012, RCT), Schema Therapy, IFS. Zawsze z *orientacją dualną* (jednoczesne utrzymanie kontaktu z teraźniejszością i traumą). **Faza 3 — INTEGRACJA I REKONEKTYWNOŚĆ:** żałoba po utraconych latach, budowanie tożsamości poza traumą, nowe relacje, plany długoterminowe. Klass i in. (1996, *continuing bonds*): integracja utraconych relacji jako trwałej części tożsamości. Cloitre i in. (2012, RCT): fazowy STAIR + NST *przewyższał* samą ekspozycję u osób po powtarzającej się traumie dziecięcej. **Uwaga krytyczna:** przejście do Fazy 2 bez wystarczającej Fazy 1 prowadzi do retraumatyzacji, dekompensacji, kryzysu suicydalnego — to klasyczny błąd terapeutów wytrenowanych tylko w protokołach PTSD.

01 Trzy fazy leczenia C-PTSD

FAZA 1 · STABILIZACJA

miesiące do lat

Bezpieczeństwo + zasoby.

Okno tolerancji, *grounding*, regulacja somatyczna, umiejętności DBT, psychoedukacja, budowanie aliansu terapeutycznego. *Bez Fazy 2, dopóki nie ma stabilności.*

FAZA 2 · PRZETWARZANIE

miesiące do lat

Praca z wspomnieniami

traumy. EMDR z modyfikacjami, STAIR + NST, Schema Therapy, IFS, podejście sensomotoryczne. Zawsze z *orientacją dualną* — kontakt z teraźniejszością + traumą.

FAZA 3 · INTEGRACJA

miesiące do lat

Życie poza traumą. Żałoba po utraconych latach, odbudowa tożsamości, relacji, planów. Wzrost potraumatyczny (ang. *posttraumatic growth*). Nie „powrót do dawnej siebie” — nowa siebie.

02 ? Kryteria gotowości do Fazy 2

Faza 1 wystarcza, gdy: (1) pacjent potrafi *regulować* aktywację — wchodzi w trudny materiał i wraca w ciągu sesji do okna tolerancji; (2) ma minimum *trzy* sprawdzone strategie *grounding*, których używa samodzielnie poza sesją; (3) bezpieczeństwo zewnętrzne jest zapewnione (nie ma aktywnej przemocy, mieszkanie, podstawowe zasoby); (4) ryzyko suicydalne i samookaleczenie są pod kontrolą (jeśli były); (5) alians terapeutyczny jest silny — pacjent ufa terapeutce, że ten nie pójdzie za szybko; (6) pacjent *chce* Fazy 2 (nie czuje się do niej zmuszany).

Jeśli choć jeden warunek nie jest spełniony: pozostać w Fazie 1, dłużej. To nie strata czasu — to oszczędność (Faza 2 przedwczesna kończy się retraumatyzacją i regresją).

03 ? Typowe ramy czasowe — bez pośpiechu

REALISTYCZNE RAMY CZASOWE

Faza 1: 6–24 miesiące (czasem dłużej).

Faza 2: 6–18 miesięcy (czasem dłużej).

Faza 3: miesiące do lat — ciągle.

Łącznie zwykle 2–5 lat lub więcej. To nie oznaka „beznadziejnej” terapii — to typowy czas dla traumy złożonej.

SYGNAŁY, ŻE TERAPIA IDZIE ZA SZYBKO

Nasilenie dysocjacji, samookaleczenia, myśli suicydalnych po sesjach. Dropout. Wrażenie, że „terapia mnie pogarsza”. Powracające retrospekcje (ang. *flashbacks*) intensywniejsze niż na początku. Brak okresów stabilności między sesjami.

Działanie: rozmowa z terapeutą o powrocie do Fazy 1. To *nie* regresja — to korekta tempa.

04 ✎ Moja samoocena — w której fazie jestem

MOJE OBECNE OBJAWY

— co najbardziej dominuje: intruzje, unikanie, dysregulacja, wstyd, samotność, dysocjacja

MOJE ZASOBY STABILIZACJI

— ile sprawdzonych strategii *grounding* używam samodzielnie poza sesją; konkretnie

BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE

— czy mam stabilne mieszkanie, czy nie ma aktywnej przemocy, czy ryzyko suicydalne jest pod kontrolą

MOJA WSTĘPNA HIPOTEZA CO DO FAZY

— jestem w Fazie 1 / na pograniczu Fazy 1–2 / w Fazie 2 / w Fazie 3; dlaczego tak sądzę

Klucz: Faza 1 nie jest *opóźnieniem* — jest **fundamentem**. ISTSS (2019): rekomendacja A (najwyższy poziom dowodów) dla podejścia fazowego w C-PTSD. Bezpośrednia ekspozycja na wspomnienia traumy w C-PTSD *bez* wystarczającej Fazy 1 jest interwencją *jatrogeniczną* (powodującą szkodę) — nasila dysocjację, samookaleczenie, ryzyko suicydalne, prowadzi do porzucenia terapii. Dlatego pierwszy rok lub dłużej często wygląda jak „wcale nie pracujemy nad traumą” — i to jest *dobry znak*. Pracujemy nad fundamentem, bez którego dalsza praca nie da efektu. Cierpliwość Fazy 1 jest inwestycją w efektywność Fazy 2.

△ Jeśli twoja obecna terapia idzie zbyt szybko (intensywniejsze objawy po sesjach, brak okresów stabilności) — to sygnał, nie porażka. Rozmowa z terapeutą o tempie jest częścią pracy, nie krytyką. Jeśli terapeuta odmawia korekty tempa lub bagatelizuje sygnały — rozważ konsultację z innym specjalistą znającym wytyczne ISTSS dla C-PTSD.